

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTE POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 1 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

Concerne : IDE et sage-femmes de l'HDJ et l'HC de Gynécologie, internes et gynécologues du pôle mère-femme.

Préambule :

→ Lors de l'entretien de la constitution du dossier médical, interroger l'existence d'un contexte de violences.

Selon la gravité et l'urgence de la situation en référer à la cadre pour une prise en charge spécifique

Possibilité :

- de plainte par la patiente
- de signalement judiciaire par le professionnel

Orientation organisée :

- à la MDFS (ou MDFE), cf formulaire adressage MDFS
- à l'UAPED (pour les mineures)

→ Contacter la psychologue référente du secteur

→ Vérifier couverture sociale, si problème de couverture sociale orientée la patiente au service PASS au 68548.

Intitulé et référence du document associé : aucun			
REDACTION : 24/07/2026 Mme E. FRANCK Cadre Sage-femme Signé	VERIFICATION : 27/07/2026 Mohcine AICH Qualiticien – Direction Qualité Signé	VALIDATION : 24/07/2026 Dr M. ACHECHE Médecin Signé	APPROBATION : 15/09/2026 Pr N. MOTTET PUPH – RSI PMF Signé
Liste de diffusion : gynécologie via le logiciel institutionnel de gestion documentaire et le classeur virtuel de Gynécologie.			
Relecture périodique du document - sans modification par : le :			

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 2 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

Sommaire :

- 1 : Prise en charge d'une patiente pour une IVG médicamenteuse** **P. 3**
 Grossesse inférieure à 13+6 SA
- 2: Prise en charge d'une patiente pour une IVG chirurgicale** **P. 8**
 Grossesse inférieure ou égale à 14 SA
- 3: Prise en charge d'une patiente pour une IVG chirurgicale** **P. 10**
 Grossesse entre 14 et 16 SA
- 4: Patiente adressée par la ville pour échec de prise en charge de l'IVG** **P. 13**
médicamenteuse
- 5 : Découverte d'une GAP à l'échographie lors du RDV d'IVG (Aucun traitement** **P. 14**
 donné jusqu'à présent)
- 6 : Si patiente mineure** **P. 15**
- 7 : Dans un contexte de violence sexuelle** **p. 16**

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 3 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

1. Prise en charge d'une patiente pour une IVG médicamenteuse: < à 13+6 SA

1 – Indications :

-**Grossesse inférieure à 9 SA** : possibilité d'une prise en charge **en extra hospitalier** (listing médecin ou sage-femme ayant une convention) sauf cas particuliers (ATCD...)

-**Grossesse jusqu'à 13+6 SA** : prise en charge **en milieu hospitalier**.

Une sage-femme doit valider cette méthode jusqu'à 9 SA

Un médecin doit valider cette méthode pour les 9 SA-13+6 SA

2- Contre-indications :

2.1) Contre-indications absolues :

- Insuffisance rénale
- Allergie à la Miféprisone
- Corticothérapie au long cours
- Troubles de l'hémostase (maladie de Willebrandt), Anémie sévère
- ATCD cardiovasculaire : angor, syndrome de Reynaud, trouble du rythme, HTA sévère
- DIU en place
- Asthme mal équilibré

2.2) Contre-indications relatives :

- ATCD médicaux : insuffisance rénale, insuffisance hépatique Malnutrition
- Grossesse gémellaire

En cas de doute ou de difficulté, soumettre le dossier à un médecin référent.

3- Avant la procédure d'interruption volontaire de grossesse :

Le dossier de la patiente doit contenir :

-**Le certificat de demande d'interruption de grossesse** datée et signé par un médecin ou une sage-femme.

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 4 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

-Un bilan biologique : NFS, bilan de coagulation (TP, TCA, fibrinogène), carte de groupe sanguin valide (2 déterminations effectuées dans la Région), BHCG

Bilan biologique réalisé en externe avant la 1^{ère} consultation SF dans la mesure du possible.

Remarque : si le rapport TCA est supérieur à 1.20 et qu'il a été réalisé dans un laboratoire extérieur, refaire le bilan de coagulation sur le CHU en demandant les facteurs de coagulation.

-Une échographie de datation : clichés + compte-rendu.

Possible de réaliser l'IVG médicamenteuse avec un sac gestationnel sans VV en l'absence de symptôme évocateur d'une GEU (Métrorragies, douleurs)

Chaque dossier supérieur à 9 SA doit être validé, avec prescription de la Mifépristone par Dr Magnin ou Dr Achèche ou CCA ou senior du pôle mère-femme.

4- Procédure d'interruption volontaire de grossesse :

4.1- Délivrance du MIFEPRISTONE :

- Chaque patiente est convoquée à 11h en HDJ de Gynécologie du lundi au mercredi, et à 14h30 le samedi et le dimanche en Gynécologie 3ème étage.
- Vérifier l'identité de la patiente
- Vérifier que le dossier est bien signé médicalement
- Faire compléter et signer par la patiente le document « formulaire de consentement » et compléter le numéro de lot de mifépristone
- Relire avec la patiente la fiche des consignes de la prise de Mifépristone qu'elle date et signe

4.2 Le jour de l'hospitalisation : 48h après la prise de MIFEPRISTONE :

- Accueil par IDE à 8h00 puis installation de la patiente en chambre individuelle, demander à la patiente de mettre une chemise fendue et un slip jetable, prise des constantes.
- Vérifier s'il y a eu des saignements, des douleurs, des nausées et /ou vomissements depuis la prise de Mifépristone.
- Prélever BHCG

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 5 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

- ->9 SA : Pose d'une voie veineuse périphérique
- Patiente à jeun solide : Liquides clairs autorisés (Thé, tisane, sirop, jus de pomme)
- Expliquer à la patiente qu'elle doit utiliser systématiquement le bassin posé sur les toilettes même pour uriner ou pour aller à la selle afin de vérifier l'expulsion de la grossesse et/ou quantifier les saignements.
- Administrer les différents médicaments :
 - Métopimazine® 7.5 mg 1 cp en sublingual si nausées
 - Paracétamol® 325 mg +Tramadol® 37.5 mg 2 cp en PER OS
 - Ibuprofène® 400mg 1 cp en PER OS

- **MISOPROSTOL**

- **Si <7 SA 400 µg** : à garder au moins 10 min en sublingual. Si vomissement de moins de 30 minutes après la prise, redonner Misoprostol 400µg.

- **Si > 7 SA 800 µg (soit 2cp)** : à garder au moins 10 min en sublingual

A partir de 10h/10h30 passer voir la patiente toutes les heures, la faire aller aux toilettes, vérifier le produit d'expulsion et mesurer l'EVA à chaque passage. Si l'EVA est supérieure à 4 : Donner un comprimé d'Acupan 30mg ou en IV 20mg +/- MEOPA. Si insuffisant demander à l'interne 14200 de venir faire un examen clinique de la patiente et conduites à tenir.

=> Si l'expulsion ne s'est pas produite vers 12h administrer Misoprostol 400µg à garder 10min en sublingual pendant 10 minutes.

- Après l'expulsion de la grossesse, effectuer 1 à 2 levers de la patiente, pour quantifier les saignements. Si les saignements sont légers voir normaux, la patiente est autorisée à manger.
- Le produit d'expulsion est récupéré et éliminer dans les DASSRI jaunes, dans le vidoir et non dans la chambre, pour incinération. Il ne peut pas être récupérer par la patiente.

- **Si saignements anormaux :**

Faire un lever, quantifier les saignements, changement de protection, et quantifier à nouveau les saignements 30 min après.

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 6 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

- **Si persistance des saignements abondants à plusieurs levers :**

Appeler l'Interne 14200 de gynécologie ou l'interne de garde 19022 pour un examen clinique +/- échographique et des conduites à tenir (surveillance la nuit dans le service de gynécologie ou reprise au bloc opératoire)

⇒ La séniorisation sera réalisée par le sénior des urgences

4.3) Sortie d'hospitalisation :

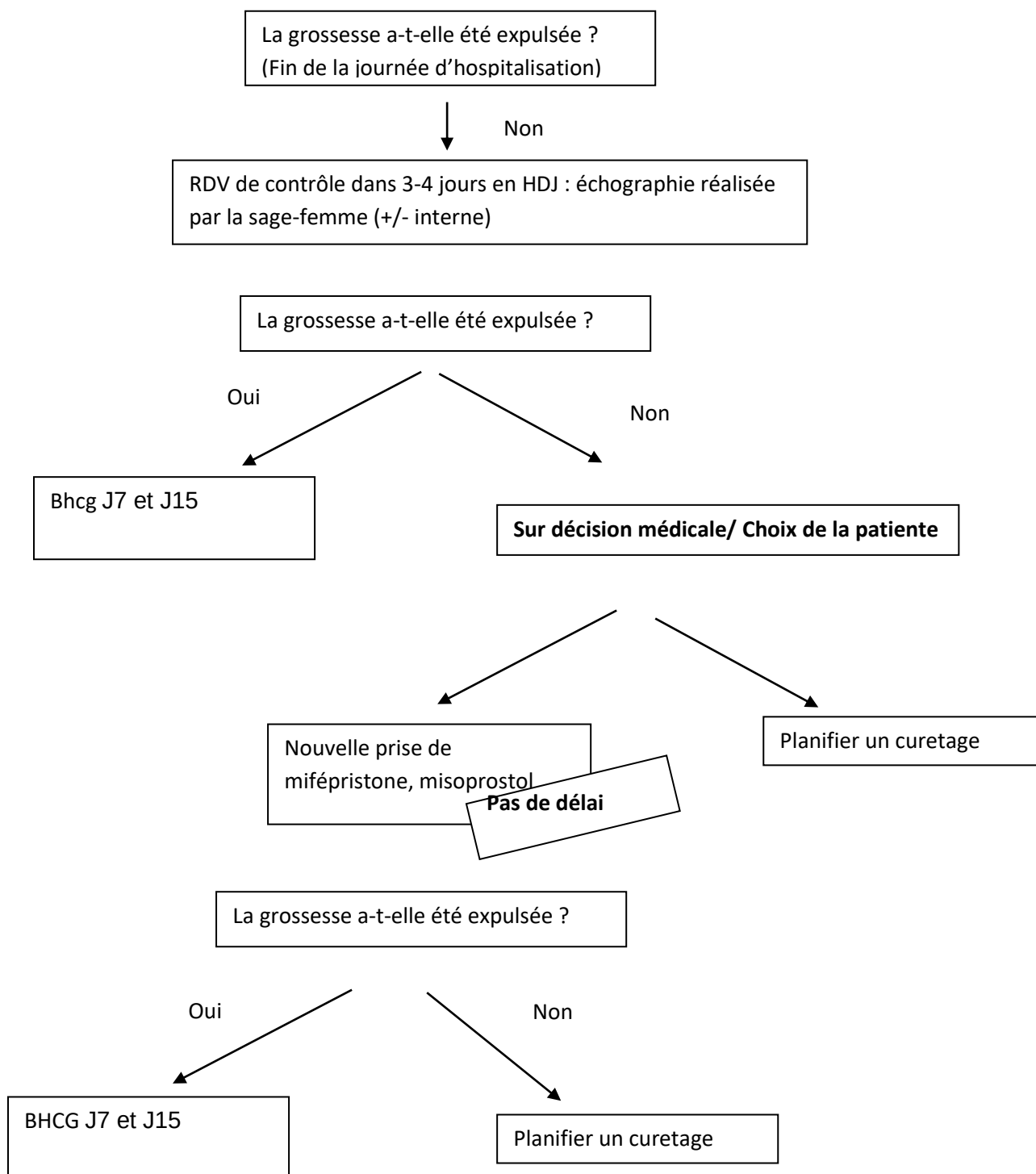
Visite de sortie faite par l'interne d'HDJ :

- Ordonnances de sortie : contraception et antalgiques pendant 48h00
- Conseils post-abortum : T°, métrorragie, N° de tel en urgence si Pb
- Si pas de contrôle échographique avant départ : Ordonnance pour surveillance cinétique beta HCG : J7 et J15 : Les résultats seront adressés aux SF réalisant les entretiens IVG
- Donner la fiche de conseils sur les suites normales de l'IVG
- Arrêt de travail si besoin
- Pose d'implant sous AL si souhait de la patiente
- Sortie autorisée entre 15h et 16h (accompagnée d'un majeur responsable) OU Sortie autorisée seule si score de Chung supérieur ou égale à 9 pour les majeurs.

Si pas d'expulsion de grossesse constatée :

- IVG < 11 SA : sortie autorisée avec un rdv dans les 3 à 4 jours en HDJ de Gynécologie pour une échographie de contrôle (Cs vers SF d'IVG), et consignes de consulter aux urgences gynécologiques si saignements trop abondants.
- IVG ≥ 11 SA : hospitaliser la patiente en gynéco au +3 pour surveillance. Réévaluation le lendemain, si échec programmation d'un curetage et sortie possible l'après-midi

Patiente reconvoquée en HDJ pour une réévaluation suite échec 1ère prise en charge médicamenteuse



 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 8 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

2. Prise en charge d'une patiente pour une IVG chirurgicale: < à 14 SA

1 – indications :

Grossesse supérieure ou égale à 8 SA

Grossesse inférieure ou égale à 14 SA.

Prise en charge obligatoire en milieu hospitalier.

2 - Application :

2.1 Avant l'hospitalisation :

- Le dossier de la patiente doit contenir :

Le certificat de demande d'interruption volontaire de grossesse daté et signé par le médecin ou la sage-femme.

Le bilan biologique : NFS, bilan de coagulation (TP, TCA, fibrinogène), une carte de groupe sanguin valide avec 2 déterminations faite dans la région, ainsi que le résultat de RAI datant de moins de 72 heures.

Une échographie de datation : clichés + compte-rendu

La consultation d'anesthésie :

Sur DIAMM, créneaux dédiés, 11h45/15h30, spécifier IVG, consultation réalisée au +1 en HDJ

Chaque patiente doit apporter le compte-rendu de cette consultation en HDJ de gynécologie, pour pouvoir récupérer le traitement préopératoire à l'IVG (400µg de Misoprostol et 1g de Paracétamol).

NB : Signer la dispensation des médicaments sur la fiche de surveillance au niveau du Misoprostol de 5h30.

La veille de l'intervention, la patiente est prévenue de l'horaire d'arrivée dans le service (appel ou sms), et on vérifie qu'elle a bien réalisé la prise de sang et qu'elle apporte les résultats le jour de l'intervention.

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 9 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

2.2 Jour de l'hospitalisation :

○ **Avant le bloc :**

- Accueil et installation de la patiente dans une chambre.
- Vérification de l'identité de la patiente, de la carte de groupe sanguin et mettre les bracelets.
- Déshabillage complet, faire mettre chemise d'opérée et culotte jetable.
- Administration de la prémédication de l'anesthésiste si besoin
- Récupérer si besoin DIU ou Implant, mettre une étiquette de la patiente et le mettre dans la pochette blanche.

○ **Retour de bloc :**

Prise de constantes, vérification des saignements, lever précoce, reprise de la boisson et de l'alimentation suivant les consignes de l'anesthésiste.

Donner l'heure de sortie autorisée pour que la personne accompagnante vienne la chercher.

NB : Le produit d'aspiration ne peut pas être récupéré par la patiente et sera incinéré.

• **Si saignements anormaux :**

Faire un lever, quantifier les saignements, changement de protection, et quantifier à nouveau les saignements 30 min après.

• **Si persistance de saignements abondants :**

Appeler l'Interne 14200 de gynécologie ou l'interne de garde 19022 pour un examen clinique +/- échographique et des conduites à tenir (surveillance la nuit dans le service de gynécologie ou reprise au bloc opératoire)

=>La séniorisation sera réalisée par le sénior des urgences

○ **Sortie d'hospitalisation :**

- Vérifier que la patiente a les documents de sortie :
 - Ordonnance de moyen de contraception et visite de contrôle 1 mois après si pose de DIU
 - Prescription d'antalgiques.
 - Arrêt de travail si besoin
 - Bon de transport si besoin (SS rembourse 65 % du tarif conventionné)
- Donner les conduites à tenir en post-abortum + les signes d'une infection génitale (T°, pertes vaginales malodorantes, maux de ventre) avec le numéro des urgences gynécologiques, s'assurer de leur bonne compréhension
- Effectuer le score de Chung à l'heure indiquée par la sortie autorisée de SSPPI. Sortie définitive autorisée accompagnée si Chung ≥ 9 .

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTE POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 10 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

3. Prise en charge d'une patiente pour une IVG chirurgicale: entre 14 et 16 SA

1 – Application :

Grossesse entre 14 et 16 SA, prise en charge obligatoire en milieu hospitalier.

2 - Application :

2.1 Avant l'hospitalisation :

Le dossier de la patiente doit contenir :

Le certificat de demande d'interruption volontaire de grossesse daté et signé par le médecin ou la sage-femme.

Le bilan biologique : NFS, bilan de coagulation (TP, TCA, fibrinogène), une carte de groupe sanguin valide avec 2 déterminations faite dans la région, ainsi que le résultat de RAI datant de moins de 72 heures.

Une échographie de datation : clichés + compte-rendu

La consultation d'anesthésie : Sur DIAMM, créneaux dédiés, 11h45/15h30, spécifier IVG, consultation réalisée au +1 en HDJ

2.2- Délivrance du médicament : 1 cp de MIFEPRISTONE :

- Chaque patiente est convoquée à 11h en HDJ de Gynécologie du lundi au mercredi, et à 14h30 le samedi et le dimanche en Gynécologie 3 -ème étage.
- Vérifier que le dossier est bien signé
- Vérifier l'identité de la patiente
- Faire lire le document accompagnant la prise de Mifépristone, la patiente doit mettre son nom et son prénom, apposer sa signature accompagnée de la mention « lu et approuvé ».
- Relire avec la patiente la fiche des consignes de la prise de Mifépristone, la patiente doit mettre son nom et prénom, la datée et la signée.
- Bien préciser que la patiente ne doit ni vomir dans une période de 45 minutes après la prise de Mifépristone, ni fumer jusqu'à la fin de la procédure (une réduction à 3 à 4 cigarettes/jour est tolérée).

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTE POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 11 / 16
	PROTOCOLE	GYNÉCOLOGIE	

- La patiente prend le 1 cp de Mifépristone en per os.

- La veille de l'intervention, la patiente est prévenue de l'horaire d'arrivée dans le service (appel ou sms), et on vérifie qu'elle a bien réalisé la prise de sang et qu'elle apporte les résultats le jour de l'intervention.

Dans chaque dossier, la prescription de Mifépristone et de Misoprostol doit être signée par un interne ou un médecin.

2.3- Jour de l'hospitalisation arrivée à 6h45 :

○ Avant le bloc :

Accueil et installation de la patiente dans une chambre.

Vérification de l'identité de la patiente, de la carte de groupe sanguin et mettre les bracelets.

Faire déshabiller complètement (vêtements et sous-vêtements), faire mettre la chemise d'opéré et la culotte jetable.

Faire remplir et signer le document de confirmation de la procédure d'interruption volontaire de grossesse, mettre le document dans le dossier.

Administration de la prémédication 6 h avant l'opération :

Pose de voie veineuse périphérique

Antalgiques IV : Ketoprofène 100 mg et Paracétamol 1 gr en mini-perfusion +/- prémédication de l'anesthésiste.

Si EVA > 4 ORAMORF : 5 gouttes 1 fois.

Si nausées administrer 1 patch de Sétofilm 4 mg en sublingual

400 µg de Misoprostol en per os ou en sublingual 30 min après antalgiques

7h15 : Pose du Dilapan par l'interne de gynécologie, si besoin administrer en simultané du MEOPA

Attention avec l'association Mifépristone + misoprostol une expulsion peut avoir lieu surveiller l'apparition de CU.

Récupérer si besoin DIU ou Implant, mettre une étiquette de la patiente et le mettre dans la pochette blanche.

Bloc prévu en début d'après-midi.

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 12 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

⇒ **Si expulsion dans le service :**

Récupérer le produit d'expulsion dans un pot à placenta et joindre la fiche de liaison « la chambre funéraire » remplie afin de l'acheminer à la Morgue où il sera incinéré.

○ **Retour de bloc :**

Prise de constantes, vérification des saignements, lever précoce, reprise de la boisson et de l'alimentation suivant les consignes de l'anesthésiste.

Donner l'heure de sortie autorisée pour que la personne accompagnante vienne la chercher.

Si saignements anormaux :

Faire un lever, quantifier les saignements, changement de protection, et quantifier à nouveau les saignements 30 min après.

Si persistance de saignements abondants :

Appeler l'Interne 14200 de gynécologie ou l'interne de garde 19022 pour un examen clinique +/- échographique et des conduites à tenir (surveillance la nuit dans le service de gynécologie ou reprise au bloc opératoire)

⇒ La séniorisation sera réalisée par le sénior des urgences

○ **Sortie d'hospitalisation :**

- Vérifier que la patiente a bien les documents de sortie suivant :
 - Ordonnance de moyen de contraception
 - Prescription d'antalgiques.
 - Arrêt de travail si besoin
 - Bon de transport si besoin (SS rembourse 65 % du tarif conventionné)
- Donner les conduites à tenir en post-abortum + les signes d'une infection génitale (T°, pertes vaginales males-odorantes, maux de ventre) avec le numéro des urgences gynécologiques, s'assurer de leur bonne compréhension
- Effectuer le score de Chung à l'heure indiquée par la sortie autorisée de SSPPI : Sortie définitive autorisée accompagnée si Chung ≥ 9 .
- Le produit d'aspiration ne peut pas être récupéré par la patiente et sera incinéré.

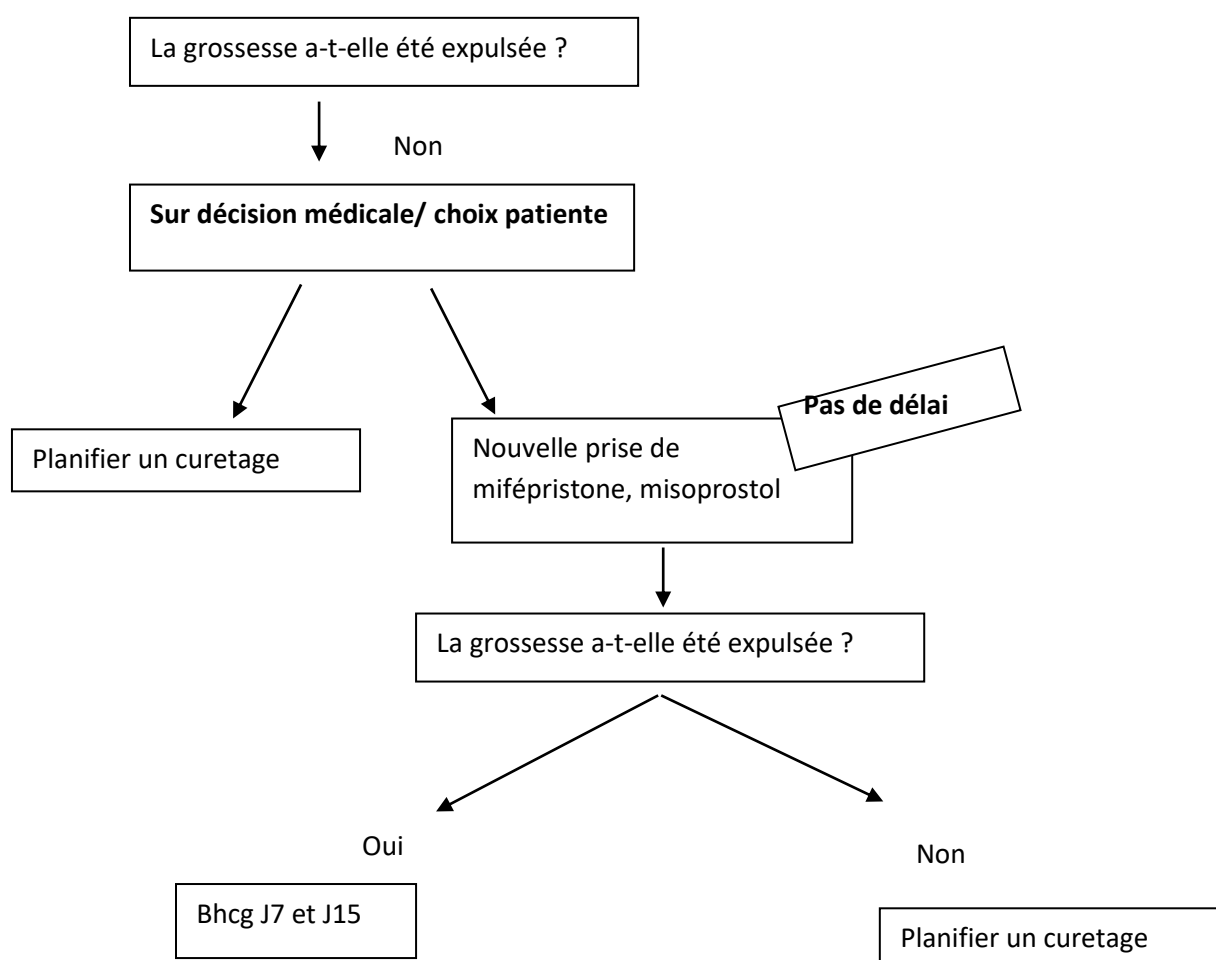
 CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 13 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

4. Patiente adressée par la ville pour échec de prise en charge de l'IVG médicamenteuse

→ RDV sur le planning d'HDJ, entretien IVG

Par téléphone au 03.81.21.81.84

Ou par mail : gynecologie-hj-inf@chu-besancon.fr



Les médecins/SF libéraux adressent par mail (gynecologie-hj-inf@chu-besancon.fr) avant le RDV d'échec une copie du dossier de la patiente (Echo initiale, écho d'échec, bilan bio, carte de groupe, consentement initial)

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 14 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

5. Découverte d'une GAP à l'échographie lors du RDV d'IVG (Aucun traitement donné jusqu'à présent)

Nous sortons du parcours IVG classique si :

Echographie : embryon > 7mm sans activité cardiaque

Ou sac gestationnel > 25 mm dans les 3 axes sans embryon

DIAMM :

- Quel parcours : Contact gynéco

- Quelle sortie : Sortie 5.6 : GAP- Demande initiale d'IVG

5.6\GAP découverte à la Cs pré IVG, PEC médicale à la maison
5.7\GAP découverte à la Cs pré IVG, PEC médicale en HDJ
5.8\GAP découverte à la Cs pré IVG, PEC chirurgicale <14SA

Quelles propositions de PEC : Med à domicile

Med en HDJ

Chir > 8 SA

Contrôle post IVG : Décroissance BHCG J7- J15

Allo interne gynécologie 14200 ou interne médecine générale pour venir signer les prescriptions

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTE POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 15 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

6. Si patiente mineure :

- **Toute consultation de demande d'IVG et d'anesthésie doit être accompagnée par un adulte** (Parent / Accompagnant majeur/Assistante sociale/soignant...)

- **Patiente ≤ 15 ans ou toute mineure dans le cadre de violence sexuelle**

Orientation à l'UAPED au 18330 en présence de la patiente. Rencontre possible avec la puéricultrice de permanence si besoin dans le même temps et/ou prise de RV avec la psychologue de l'UAPED pour l'entretien psychosocial obligatoire.

- **Si les parents sont présents** : faire signer l'autorisation d'opérer par au moins l'un des parents (003CME210ER01005)
- **Si la patiente ne souhaite pas informer ses parents** :
 - Demander l'identité et le numéro de téléphone du majeur accompagnant
 - Attestation confidentielle à compléter (pour BDE)
- **Si pas de majeur accompagnant** : solliciter l'assistante sociale (Secrétaires 69282)

- **Patiente entre 15 et 18 ans**

Une attestation d'entretien psycho social est obligatoire (majoritairement effectué par une psychologue du pôle mère-femme)

- **Si les parents sont présents** : faire signer l'autorisation d'opérer par au moins l'un des parents (003CME210ER01005)
- **Si la patiente ne souhaite pas informer ses parents** :
 - Demander l'identité et le numéro de téléphone du majeur accompagnant
 - Attestation confidentielle à compléter (pour BDE)
- **Si pas de majeur accompagnant** :
 - Solliciter l'assistante sociale (Secrétaires 69282)

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTE POLE MF	PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE		CHUB_DOC_PT_0065 Version 02 Page 16 / 16
	PROTOCOLE	GYNECOLOGIE	

7. Si IVG dans le cadre de violences sexuelles

1/ Avec réquisition du produit d'expulsion :

- Une demande de réquisition du procureur, gendarmerie, police aura été faite au préalable et jointe au dossier.
 - Convenir avec les forces de l'ordre compétentes, des modalités de récupération du produit d'expulsion
 - Mettre le produit d'expulsion dans :
 - un flacon sec si il y a une grande quantité de tissu avec des fragments embryonnaires
 - un flacon de sérum physiologique si il n'y a que quelques arbrs villeux et beaucoup de sang/caillots
 - Les forces de l'Ordre compétentes :
 - Peuvent venir chercher le produit d'expulsion de suite => leur remettre
 - Ne peuvent pas venir
 - Informer R Mathevet tel : 68 965
 - Transmettre le produit d'expulsion à l'espace tampon de la chambre mortuaire, conservation à +4°C (nécessité de conditionnement avant cryoconservation)
- Avec la Fiche liaison chambre mortuaire expulsa IVG RJ RPSP : 090 ...210...ER 2026

2/ Dossier conservatoire de Recueil de preuves sans plainte : EXCLUSIVEMENT pour patientes MAJEURES

- Conservation sécurisée du prélèvement durant 3 ans
 - Transmission sur réquisition dans le cadre d'une procédure judiciaire ou destruction au-delà des 3 ans en l'absence de procédure
 - Recueil du consentement écrit de la patiente à conserver dans le dossier et donner une copie à la patiente
 - Mettre le produit d'expulsion dans :
 - un flacon sec si il y a une grande quantité de tissu avec des fragments embryonnaires
 - un flacon de sérum physiologique si il n'y a que quelques arbrs villeux et beaucoup de sang/caillots
 - Transmettre le produit d'expulsion en anatomopathologie afin qu'il soit techniqué avant son dépôt en chambre mortuaire
- Fiche liaison chambre mortuaire expulsa IVG RJ RPSP : 090 ...210...ER2026

3/Si danger immédiat :

Hospitalisation possible dans un lit de protection en gynécologie